Badania hormonalne

Co zbadać i jak przygotować się do diagnostyki?

WSKAZANIA | PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ | LISTA BADAŃ



OH! CLUB



Cześć! Tu Klaudia Kubrak, dietetyk kliniczny z 8-letnim doświadczeniem.

Na co dzień **pomagam kobietom lepiej zrozumieć swoje hormony, uporządkować diagnostykę i znaleźć obszary,** na które warto zwrócić większą uwagę.

Przez lata pracy z kobietami widzę, jak często **pojedynczy wynik potrafi wywołać więcej pytań niż odpowiedzi**. Dlatego przygotowałam dla Ciebie ten materiał — żebyś mogła podejść do swoich badań bardziej świadomie i wiedziała, **od czego zacząć.**

Pamiętaj, że **zdrowia hormonalnego nie ocenia się na podstawie jednego wyniku.** Znaczenie mają wzajemne zależności hormonów, objawy, faza cyklu oraz styl życia.

Nie wszystkie badania hormonalne wykonuje się w tym samym momencie cyklu. Przy każdym z nich znajdziesz informację, kiedy najlepiej je wykonać. Jeśli nie miesiączkujesz, część badań można wykonać niezależnie od fazy cyklu.

Wyniki badań warto analizować **w szerszym kontekście** - uwzględniając m.in. sposób odżywiania, aktywność fizyczną, sen, stres oraz występujące objawy. Czasem podstawowa diagnostyka daje jasny kierunek, a czasem potrzebne jest jej poszerzenie.

Potraktuj tę listę jako punkt wyjścia - narzędzie, które pomoże Ci lepiej przygotować się do rozmowy ze specjalistą i bardziej świadomie spojrzeć na swoje zdrowie hormonalne.

Pozostańmy w kontakcie:

Przygotowanie do badań

Pamiętaj o odpowiednim przygotowaniu się do badań:

- Ostatni posiłek zjedz min. 12 h przed badaniem, zadbaj aby był lekkostrawny i nie zbyt obfity.
- Dzień przed unikaj intensywnego treningu – a najlepiej nie podejmuj wysiłku fizycznego na 24h przed badaniem.
- Dzień przed unikaj spożywania alkoholu.
- Dzień przed pobraniem powstrzymaj się od aktywności seksualnej. W szczególności w przypadku oznaczenia hormonów m.in. prolaktyny.
- Przed badaniem unikaj stresujących sytuacji.
- Badania wykonaj w godzinach porannych (najlepiej między 7 a 10).
- Bądź na czczo.
- Rano wypij szklankę wody.
- Bądź wyspana i wypoczęta.
- Poinformuj lekarza o zażywanych lekach i zapytaj czy występuje konieczność ich ostawienia przed badaniem.
- Jeśli przyjmujesz lewotyroksynę (Euthyrox, Letrox, Novothyral) - przyjmij lek dopiero po badaniu.
- Przed wykonaniem badań należy odstawić wszystkie przyjmowane suplementy na 3 dni. (To również dotyczy biotyny. Jej przyjmowanie może dawać fałszywe wyniki takich parametrów jak: TSH, ft3, ft4, LH,, FSH, prolaktyna, insulina , SHBG.)
- Nie wykonuj badań w trakcie choroby lub bezpośrednio po jej przebyciu.

Badania podstawowe

Badania podstawowe to badania, które zawsze warto przeprowadzać, niezależnie od rodzaju problemu, z którym się borykasz.

Zalecam wykonywanie ich co najmniej dwa razy w ciągu roku.

LISTA BADAŃ:

- morfologia z rozmazem,
- lipidogram,
- próby wątrobowe (AST, ALT, GGTP),
- glukoza, insulina na czczo,
- żelazo, ferrytyna,
- wit.B12, kwas foliowy, wit. D,
- TSH, ft3, ft4,
- cytologia (raz w roku),
- USG piersi (raz w roku),
- przegląd stomatologiczny
- samobadanie piersi (raz w miesiącu, najlepiej 2-3 dni po miesiączce).

Lista badań

trądzik hormonalny **(na linii żuchwy, policzkach, plecach i klatce piersiowej)**	• testosteron wolny, DHT, androstendion, DHEA-S, SHBG, LH, FSH - 3-5 dzień cyklu • estradiol, progesteron (7 dni po owulacji lub 7 dni przed spodziewaną miesiączką) • insulina, glukoza na czczo • prolaktyna - między 20 a 21 dniem cyklu • kortyzol na czczo (w godzinach porannych)
problemy ze schudnięciem **(pomimo wprowadzonego deficytu kalorycznego i aktywności fizycznej)**	• TSH, ft3, ft4, antyTPO, antyTG • insulina na czczo, glukoza na czczo • kortyzol na czczo • leptyna (nie jest to jednak warunek konieczny)
podejrzenie PCOS **(rzadkie miesiączki lub ich brak, objawy nadmiaru androgenów: trądzik, nadmierne owłosienie, łysienie), obraz policystycznych jajników w USG**	• testosteron, androstendion, DHEA-S, SHBG LH, FSH - 3-5 dzień cyklu • TSH, ft3, ft4 • prolaktyna - między 20 a 21 dniem cyklu • kortyzol na czczo • AMH • glukoza, insulina na czczo (przy podejrzeniu IO - krzywa glukozowo-insulinowa) • witamina D • USG jajników
nieregularne miesiączki **(zbyt krótkie lub długie cykle)**	• LH, FSH • estradiol, progesteron (7 dni po owulacji lub 7 dni przed spodziewaną miesiączką) • anty-TPO, anty-TG • kwas foliowy • witamina B12 • prolaktyna (w przypadku podejrzenia hiperprolaktynemii)
podejrzenie dominacji estrogenowej **(bolesne miesiączki, zbyt intensywne miesiączki, torbiele w piersiach, PMS, tkliwe piersiami przed okresem, trądzik (nasilającym się głównie przed miesiączką czy po owulacji), mięśniaki macicy**	• estradiol, progesteron (7 dni po owulacji lub 7 dni przed spodziewaną miesiączką) • kortyzol na czczo (w godzinach porannych) • prolaktyna - między 20 a 21 dniem cyklu
tkliwość piersi	• progesteron, estradiol - 7 dni po owulacji lub 7 dni przed spodziewaną miesiączką • USG piersi • TSH • jod z DZM (dobowa zbiórka moczu) • kortyzol na czczo (w godzinach porannych)

Lista badań

budzenie się w nocy	• pasożyty z kału (3 próbki), • kortyzol, • TSH, ft3, ft4 • pomiar pulsu spoczynkowego (przed wstaniem z łóżka)
niskie libido	• estradiol - 3-5 dzień cyklu lub 7 dni po owulacji • progesteron - 7 dni przed pierwszym dniem miesiączki (w teorii 21. dzień cyklu) • prolaktyna - 7 dni przed pierwszym dniem miesiączki (w teorii 21. dzień cyklu) • testosteron wolny, testosteron całkowity • panel tarczycowy
problemy z płodnością	• AMH (ocena rezerwy jajników) • progesteron, estradiol (7 dni po owulacji lub 7 dni przed spodziewaną miesiączką) • glukoza/insulina na czczo; (przy podejrzeniu IO - krzywa glukozowo-insulinowa) • prolaktyna - 7 dni przed pierwszym dniem miesiączki (w teorii 21. dzień cyklu) • panel tarczycowy • pasożyty z kału (3 próbki), • testosteron wolny, DHT, androstendion, DHEA-S, SHBG, LH, FSH - 3-5 dzień cyklu
podejrzenie insulinooporności **(przysypianie po posiłkach, ogromna ochota na słodkie, niski poziom energii, uczucie zmęczenia)**	• glukoza, insulina na czczo (HOMA-IR) • hemoglobina glikowana (warto jeszcze dobadać krzywą glukozowo-insulinową - na czczo, po godzinie, po dwóch)
podejrzenie niedoczynności tarczycy, Hashimoto **(znaczne wahania nastroju, przybieranie na masie ciała, brak koncentracji, "mgła mózgowa", senność, zmęczenie, zimne stopy i/lub dłonie, suchość skóry)**	• TSH, fT3, fT4 • anty-TPO, anty-TG • USG tarczycy • CRP
wypadanie włosów	• żelazo, ferrytyna • panel tarczycowy • witamina B12, kwas foliowy, fosfataza zasadowa • witamina D (25-OH-D3) • testosteron wolny, DHT, DHEA-S, androstendion • glukoza, insulina na czczo

NIE MUSISZ ROBIĆ WSZYSTKIEGO SAMA 🤍

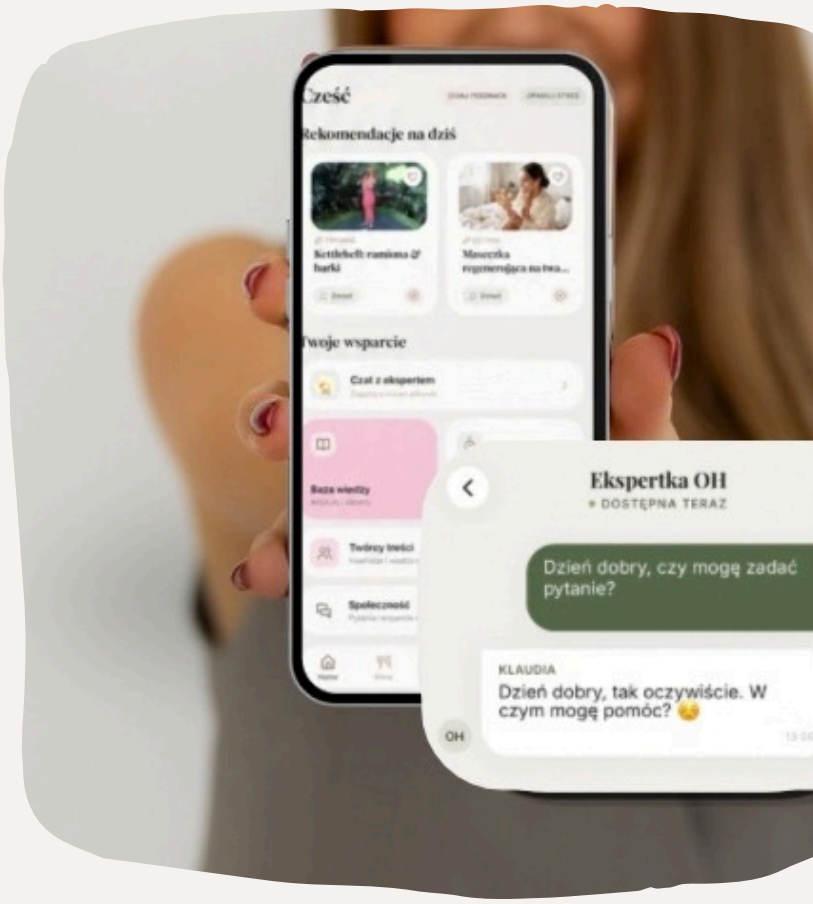
Badania to pierwszy krok.
Teraz czas zadbać o siebie także na co dzień.

W **OH! Club** znajdziesz wiedzę, wskazówki i wsparcie, które pomogą Ci **lepiej zrozumieć swoje ciało i zadbać o swoje hormony krok po kroku.**

Pobierz OH! Club na swój telefon i zacznij od małych zmian:

Pobierz na iOS

Pobierz na Androida



OH! CLUB